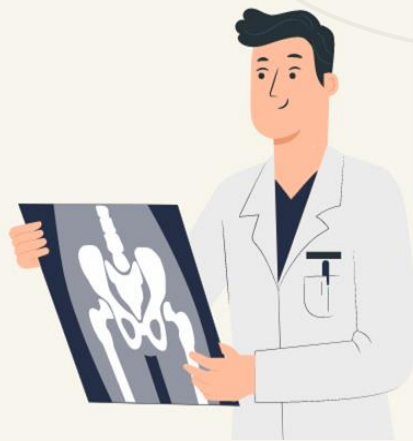


"C'est quoi être Normal ? Qu'est-ce qui est "normal", qu'est-ce qui est "pathologique" ?

Le médecin a un double rôle : SOIGNER et ENSEIGNER.
L'examen clinique = SYMPTOMES observés par le médecin.
LE NORMALE < CLINIQUE < LE PATHOLOGIQUE

Foucault confirme que la médecine ne doit pas s'intéresser au diagnostic et au traitement seulement mais également à l'homme en bonne santé pour définir l'homme modèle (normal).

-**La normalité** renvoie à des conflits conceptuels au surlendemain. Ce qui en résulte une certitude et une incertitude, une évidence incontestable et un doute contestable, une vitalité et une banalité.



Approche statistique : la plus couramment utilisées .**QUETELET, au 19ème siècle a tenté d'appliquer la courbe de Gauss aux hommes, pour s'appuyer sur des données bien réelles**, Au centre de la courbe, au sein de la majorité, se trouve selon QUETELET l'homme "normal", "standard". on peut considérer le point où, lorsque l'on s'écarte de la moyenne, on quitte la normalité pour rentrer dans l'anormalité

Approche sociale : proche de l'approche statistique, sauf que la définition de la norme nettement emprunte de subjectivité et elle est variable selon l'époque et la société. pour être normal=d'être bien adapté socialement >>**WINNICOTT a décrit ce que l'on appelle les personnalités en "faux-self"** . qui fonctionne comme une couche artificielle qui protège contre l'angoisse et l'agression, mais il reste un déséquilibre profond à l'inverse se trouve le vrai-self. Un faux-self ne gêne pas dans la société. N'importe qui peut définir la normalité, selon Bergerett :« Si la normalité devient relative selon un idéal collectif, on ne connaît que trop les risques courus.»

Approche "absence de pathologie" :**BUSS a définit la pathologie selon trois critères d'inconfort (l'état de souffrance et sa détresse personnelle), de bizarrerie et d'inefficacité.** Une personne qui présente des troubles, ne ressent pas forcément un état d'inconfort, et inversement, une personne qui ne présente aucun trouble (les faux-selves), ne ressent pas nécessairement un état de bien-être les études de Framingham sur les risques cardiovasculaires, en mesurant par exemple la tension artérielle et diagnostiquer le malade en hypertension, sans qu'il sente aucun mal)

Représentations sociales de la santé et de la maladie :

1. La théorie des représentations sociales (RS) :

repose sur le postulat : « toute réalité est représentée et appropriée par l'individu ou le groupe, reconstruite par son système cognitif, intégrée dans son système de valeurs dépendant de son histoire et du contexte social et idéologique qui l'environne. = un outil efficace pour discuter la maladie, le traitement... etc. par le patient, mais aussi lui permettent de côtoyer les professionnels de santé.

2. Niveaux explicatifs de l'approche des RS :

>> **Suite au niveau 04** - Les fonctions des RS sont de 04 ordres : fonction de savoir, identitaire, d'orientation et justificatrice. La fonction d'orientation confirme cette théorie.

La proposition de la théorie des RS a ouvert un champ de recherches par MOSCOVICI : « Une forme de connaissance socialement élaborée et partagée, à visée pratique et concourant à la construction d'une réalité commune à un ensemble social. ». Selon lui, la RS a double rôle : elle permet une position sociale et elle fournit un référentiel commun pour la communication.

NIVEAU 01

Le niveau intra individuel, renvoie à la gestion du patient face sa rencontre de la maladie et du traitement.
Souvent, ça implique un total remaniement identitaire jusqu'à la revue des valeurs.

NIVEAU 02

Le niveau **inter individuel, ou situationnel**, renvoie à la relation du patient avec son médecin, son entourage

NIVEAU 03

relations du patient avec l'institution de la santé, caractérisée par les professionnels de santé qui renvoient au sujet une théorie dite savante de la maladie et de son traitement
On se situe là un niveau **positionnel et des relations inter groupales**

NIVEAU 04

la prise en charge du sujet le rend un élément du système, qu'il transforme à son tour. C'est une **Co construction**. Tous les acteurs en relation avec le malade appartiennent à une certaine société qui véhicule des croyances et des RS de la maladie. (Ex : L'annonce du diagnostic inscrit le malade à un certain regard social. Socialement, être malade du sida n'est pas la même chose qu'être diabétique). Il s'agit du **niveau idéologique et culturel** au sein duquel le patient évolue

3. La représentation de la santé : (HERZLICH) Une étude montrée que la RS intègre 2 notions opposées : LA SANTE ET LA MALADIE. C'est une lutte entre le mode de vie, élément actif qui déclenche les maladies et la santé de l'individu pour l'adaptation au mode de vie, soit comme la victoire de la maladie par la dégradation de la santé.

>> La santé peut être perçue négativement comme absence de maladie ou positivement comme état.

>> on a 3 représentations de la santé : - La santé vide : absence de maladie.

- Le fond de santé : la résistance de l'individu aux maladies.

- L'équilibre : un bien-être physique et psychologique. Sur le plan vécu, c'est l'actualisation des possibilités du fond de santé, et sur le plan ressenti, c'est l'opposition à la santé vide.

4. La représentation de la maladie : - La maladie destructrice : C'est une des conséquences dévastatrices de l'inactivité.. - La maladie libératrice : L'inactivité est une libération, un repos, un allègement et une défense face aux exigences.. - La maladie métier : Le malade lutte activement contre la maladie. L'inactivité permet un allègement et une énergie pour la lutte. Le malade redoute la maladie, mais l'accepte. L'adaptation est possible dans les maladies chroniques par un nouveau mode de vie. L'efficacité des soins dépend du moral et de la volonté. Il n'y a pas d'obéissance stricte au médecin mais une relation, égale à de coopération et d'échange.

La maladie libératrice s'exprime chez les personnes non-malades ou jamais confrontées à une maladie grave. Les deux autres conceptions correspondent aux différentes étapes de la maladie perçue d'abord. Ces résultats ont inspiré de nouvelles recherches sur les Health beliefs et les comportements sains.

L'étude des RS est développée concentrant sur les pratiques à type d'affection

. **Notion de vulnérabilité** = fragile, sensible, **qui peut être blessé**, frappé



→ En physique « capacité d'un matériau à revenir à son état initial après un choc »

→ En psychologie « la capacité de s'adapter à un environnement changeant »

>> selon Thomas on a deux notions : la fêlure (la zone d'atteinte)

la blessure (matérialisation de l'atteinte).

>> permet d'analyser, de calculer et d'anticiper les risques et l'impact.

ALORS: la vulnérabilité est exposition au risque + la mesure de la susceptibilité de l'individu exposé à la réalisation du dommage.

. **Notion de stigmatisation** : Selon **Erving Goffman**, « Un stigma est un type de relation entre l'attribut et le stéréotype. »

>> les stigmates étaient associés à des marques corporelles et à des personnes mauvaises.

>> la stigmatisation est le résultat de l'apposition d'étiquettes sociales soit officielles (Ex : les lois), ou reliées au jugement personnel.

« **déstigmatisation** » terme exprime l'idée

de la suppression de la stigmatisation ou du combat contre les stigmates



trois catégories de stigmates selon Goffman

les stigmates corporels :

défauts
physiques
tels un
handicap ou
une
malformation

les stigmates liés à la personnalité ou au passé de l'individu

- manque de volonté
- Malhonnêteté
>> atteinte de maladie
mentale,

les stigmates tribaux

se transmettent de génération
en génération et qui font
**référence à
l'ethnie, à la religion ou à la
nationalité de l'individu.**

GOOD LUCK



{وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ..}

(يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ)